

IP09-28 中文完整翻譯

BPH 手術是否為 LUTS 男性退出藥物治療的出口？回顧性研究

IP09-28

BPH 手術是否為下泌尿道症狀男性退出藥物治療的出口？回顧性研究

原題： Is Surgery for Benign Prostatic Hyperplasia an Offramp for Medical Therapy in Men with Lower Urinary Tract Symptoms? A Retrospective Review

作者： Aiden Masters, Ben Rubin, Jake Bleau, Sarah Kohl, Nicholas Khoo, Clara Goebel, Matt Mullen, Sidney Gregorek, Shane Cauley, Jenna Winebaum, Brian Irwin, Richard Grunert, Mohammad Mohaghegh

單位： University of Vermont Larner College of Medicine ; University of Vermont Medical Center

來源檔案： scraper/data/posters/IP09-28.pdf

前言

良性攝護腺肥大或增生 (benign prostatic hyperplasia, BPH) 是高齡男性最常見的泌尿科疾病之一，會造成顯著的下泌尿道症狀 (lower urinary tract symptoms, LUTS)。

當藥物治療失敗，或患者希望有較持久的解決方式時，常會進行手術治療，包括 TURP、雷射治療，以及微創手術等。然而，即使許多患者選擇手術治療的重要動機是希望停止藥物治療，術後仍常見持續使用藥物。

因此，了解手術後的藥物使用型態，對於術前諮詢與設定術後期待非常重要。

方法

- 使用 TriNetX Diamond Network 進行回顧性世代研究，資料期間為 2006 年至 2025 年 9 月。
- 納入接受初次 BPH 手術的成年男性 (年齡 ≥ 18 歲)。
- 評估五類藥物：
 - alpha-blockers
 - 5-alpha-reductase inhibitors (5ARIs)
 - phosphodiesterase type-5 inhibitors (PDE5is)
 - antimuscarinics
 - B3 agonists
- 評估 BPH 手術後 1 年的術後藥物使用情形。

結果

圖 1：術後 1 年最常見的一線治療

樣本數為 50,273 人。圓餅圖顯示術後 1 年最常見的藥物治療組合如下：

治療類別	比例
Alpha blocker 單一治療	28.1%
未使用藥物	22.5%
Antimuscarinic 單一治療	17.6%
Alpha blocker + 5ARI	10.5%
5ARI 單一治療	8.7%
Alpha blocker + antimuscarinic	4.5%
PDE5 inhibitor 單一治療	2.2%
Alpha blocker + 5ARI + antimuscarinic	1.9%
其他合併治療	1.8%
B3 agonist 單一治療	1.4%
5ARI + antimuscarinic	1.0%
Alpha blocker + PDE5 inhibitor	0.5%

表 1：患者族群人口學資料

平均接受 index surgery 時的年齡為 70.4 ± 9.27 歲。

種族	患者數	佔 cohort 比例
White	38,043	75.7%
Black or African American	4,430	8.81%
Unknown	3,826	7.61%
Asian	2,204	4.38%
Other	1,770	3.52%

討論

- 術後 1 年時，77.5% (n = 38,983) 的患者至少仍被處方一種 BPH 相關藥物。
- 術後 1 年時，22.5% (n = 11,290) 的患者不需要任何藥物治療。
- 單一藥物治療是最常見的術後治療型態 (74.7%)。
- 在接受單一藥物治療者中，最常見的是 alpha-blocker (36.2%)。
- 合併藥物治療佔所有術後治療型態的 25.3%。
- 最常見的合併治療為 alpha-blocker + 5ARI (13.5%)。

結論

本研究顯示，對多數男性而言，BPH 手術並不代表下泌尿道症狀患者可以退出藥物治療；大多數患者在解除出口阻塞手術後 1 年，仍使用一種或多種藥物。

這些結果可協助醫療提供者在 BPH 手術治療後，就術後藥物使用情形向患者進行諮詢，並設定較符合現實的期待。此外，本研究也凸顯，在 BPH 手術後狀態下，男性 LUTS 仍需要進一步研究。

限制

本研究的限制在於無法確認患者是否確實正在服用這些藥物。由於資料收集方式的限制，研究只能顯示患者仍被處方研究中納入的藥物。尚不清楚這些藥物是否仍為主動處方，或只是因醫師忘記移除而保留在患者用藥清單上。

版型資訊

Research Poster Presentation Design © 2012
www.PosterPresentations.com